歩き方がおかしい

歩行パターンでわかる隠れた病気を脳神経内科医が解説

その症状、大丈夫？ #11

医知創造ラボ ～脳神経内科医がAIで紡ぐ最新医療情報～

こんな経験、ありませんか？

- 🚶 家族に「歩き方が変」と言われた
- 🦶 つまずきやすくなった
- 🌀 まっすぐ歩いているつもりがふらつく
- 👣 歩幅が小さくなった気がする
- 🦵 長く歩くと足が重くなって休みたくなる

歩行のメカニズム — なぜ歩き方で病気がわかる？

🧠	**大脳・基底核**	歩行の開始・速度・リズムを制御 パーキンソン病→小刻み歩行
●	**小脳**	バランス・協調運動を調整 小脳疾患→ふらつき歩行
🦴	**脊髄**	脳からの運動指令を手足に伝える 脊髄障害→つっぱり歩行
⚡	**末梢神経・筋肉**	筋肉を動かし関節を制御 神経障害→つま先が上がらない

※ 歩行は脳から筋肉まで全身の協調で成り立つ → どこが障害されたかで歩き方が変わる

歩行パターンでわかる病気 — 前半

小刻み歩行

歩幅が狭く前かがみ
すくみ足・腕振りが減る

原因
パーキンソン病
正常圧水頭症

痙性歩行

足がつっぱり円を描くように
振り出す（ぶん回し歩行）

原因
脳卒中後遺症
脊髄障害

失調性歩行

ふらつきが大きく酔っ払いのよう
足を広げてバランスをとる

原因
小脳疾患
脊髄小脳変性症

歩行パターンでわかる病気 — 後半

鶏歩

つま先が上がらず膝を高く上げて
ペタペタと歩く（下垂足）

原因
腓骨神経麻痺
腰椎椎間板ヘルニア

動揺歩行

体を左右に揺らしながら歩く
（あひる歩き）

原因
筋ジストロフィー
近位筋の筋力低下

間欠性跛行

歩くと足が重く痛くなり
休むと回復して歩ける

原因
脊柱管狭窄症
末梢動脈疾患

歩行障害の原因 — 心配度で分類

軽度	加齢による筋力低下	歩幅の減少・歩行速度の低下。筋トレで改善可能
要注意	パーキンソン病	小刻み歩行・すくみ足。早期治療で症状コントロール可能
要注意	脊柱管狭窄症	長く歩くと足が重い。前かがみや休憩で回復
要注意	正常圧水頭症	小刻み歩行＋認知症＋尿失禁。手術で改善可能
緊急	脳卒中	突然の歩行困難＋片側の脱力・ろれつ障害

見逃されやすい原因 — 正常圧水頭症（iNPH）

治る認知症とも呼ばれる — 手術で改善可能な歩行障害

歩行障害

小刻み歩行・すくみ足
足が床に張り付く感覚
最も早期に出現

認知症

物忘れ・注意力低下
意欲の減退
アルツハイマーと誤診されやすい

尿失禁

頻尿・切迫性尿失禁
間に合わない
進行すると出現

※ 髄液シャント術で歩行障害の約8割が改善 — 早期発見が重要

自分でできるチェック — 歩行の変化

1

歩幅と速度を確認

横断歩道を青信号で渡りきれるか？
以前より歩幅が小さくなっていないか

2

バランスを確認

まっすぐ歩けるか？ふらつかないか
方向転換でよろめかないか

3

左右差を確認

片足だけ引きずっていないか
靴底の減り方に左右差がないか

こんな場合はすぐ受診 — 危険なサイン

- 突然歩けなくなった＋片側の脱力・ろれつ障害（脳卒中）
- 数日〜数週間で急速に歩行が悪化（脊髄障害・ギラン・バレー）
- 歩行障害＋排尿障害がある（脊髄圧迫の可能性）
- 転倒を繰り返すようになった（骨折・頭部外傷のリスク）
- 歩行障害＋認知機能低下＋尿失禁（正常圧水頭症の三徴）

受診の目安 — 緊急度3段階

● すぐ受診

突然の歩行困難＋片側脱力・ろれつ障害
急速に歩行が悪化している

脳卒中・脊髄障害
→119番

● 早めに受診

数週間〜数ヶ月で徐々に歩きにくくなった
転倒が増えた・歩幅が小さくなった
認知機能低下や尿失禁を伴う

脳神経内科で精査
MRI・歩行分析

● 様子見OK

疲労や体調不良時の一時的なふらつき
長時間の歩行後の足の重さ

休息で改善すれば
心配不要

よくある質問 Q&A

Q. 歩き方がおかしいのは何科に行けばいい？

A. まず脳神経内科をおすすめします。歩行障害の原因は脳・脊髄・末梢神経・筋肉と多岐にわたりますが、脳神経内科はこれらを総合的に診断できます。必要に応じて整形外科等に紹介します

Q. パーキンソン病の歩行障害は治りますか？

A. 薬物療法で歩行を含む症状を大幅に改善できます。特に早期から適切な治療とリハビリを行うことで、長期間にわたって良好な歩行機能を維持できます

Q. 正常圧水頭症の手術は安全ですか？

A. 髄液シャント術は確立された手術で、歩行障害の改善率は約80%と報告されています。高齢者でも比較的安全に行える手術です

まとめ — 歩き方がおかしいと感じたら

1 歩行パターンが原因疾患を示唆する

小刻み→パーキンソン病
ふらつき→小脳 / つっぱり→脊髄

2 正常圧水頭症は手術で改善可能

歩行障害＋認知症＋尿失禁の三徴に注目

3 歩行障害は脳神経内科で総合的に診断できる

脳・脊髄・末梢神経・筋肉のどこが問題かを判断

ご視聴ありがとうございました

チャンネル登録・高評価よろしくお願いします！

🔗 ブログ記事で詳しく読む（概要欄にリンク）

🔍 歩行セルフチェックツール（概要欄にリンク）

次回予告

#12 頭をぶつけた後、病院に行くべき？

医知創造ラボ